最重要
（3）有 PCI 条件者首选 PCI（直接 PCI）

不是最好的再灌注治疗方法,溶栓后遗留的渣渣容易导致微循环栓塞
（4）无 PCI 条件者或预计直接 PCI＞2 小时进行溶栓

溶栓 禁忌症 注意：高危肺栓塞不考虑溶栓禁忌症	①脑卒中、中枢神经系统病变 腔隙性梗死不是禁忌症 ②未排除主动脉夹层、未控制严重高血压（＞180/110）高血压3级 ③近期活动性内脏出血、创伤史（心肺复苏、骨折等）、大手术、不能压迫部位（肝或肾）的大血管穿刺 不是桡A穿刺 （脑袋、创伤、血管）
溶栓药	特异性纤溶酶原激活剂特异作用于血栓处的纤溶酶原：阿替普酶 rt-PA、重组人尿激酶原 pro-UK 等（注意：尿激酶为非特异性溶栓药） 对全身影响小
溶栓 再通标准	直接：冠脉造影（有创） “血来了心肌又活过来了” 间接：CK-MB 高峰提前出现（＜14 小时）、胸痛 2 小时内基本消失、2 小时内再灌注心律失常如一过性非阵发性室速——加速性室性自主心律/缓慢型室速/渐发渐止（活了→放电了、元气大伤）、抬高 ST 段 2 小时内回降＞50%（2222+14 又可以打扑克了）
溶栓成功	行冠脉造影，必要时再行 PCI 缓解重度残余狭窄的血管（溶栓治疗再通者的 PCI）
溶栓不成功	行冠脉造影，对未再通的动脉立即 PCI（补救性 PCI）

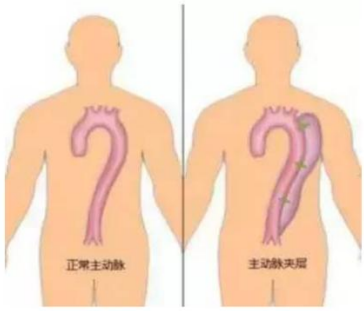
（5）PCI、溶栓均无效→在 6-8 小时内紧急冠脉旁路移植术

2.抗心律失常治疗

室颤、持续多形性室速	电复律
室早、室速	利多卡因→胺碘酮（早上速度卡点）β-R拮抗剂也能用(本章没写)
室上性快速型	美托洛尔、胺碘酮
缓慢型	阿托品，二度II型和三度房室阻滞起搏器

3.其余治疗同 UA/NSTEMI

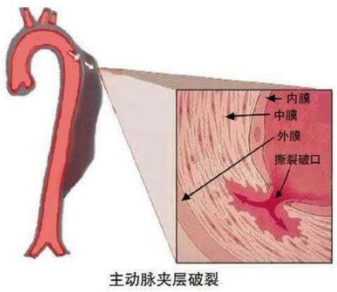
（四）急性心梗的鉴别诊断



1.不稳定型心绞痛
①心肌坏死标志物：心梗明显升高
②心电图：心梗特征和动态性改变
③时间：心梗持续数小时甚至 1-2 天
④频率：心梗发作不频繁
⑤血压：心梗可降低（心源性休克） VS心绞痛血压可↑(交感神经兴奋)
⑥坏死物吸收的表现：心梗常有

不能因为血压没低就排除心肌梗死
①与心肌坏死范围有关
②可能患者本身有高血压

不能做主动脉内球囊反搏
2.主动脉夹层 与撕裂范围有关
①胸痛一开始即达高峰、呈撕裂样，可向腰腹部及下肢放射
②双上肢血压不等（对比：主动脉缩窄上肢血压明显高于下肢）
③无心肌坏死标志物 也可出现上肢血压高于下肢血压(出现在降主动脉时)
④可有主动脉瓣区杂音 主动脉根部扩张→主动脉瓣关闭不全



主动脉夹层破裂

马冬梅高颜值假:马凡综合征、梅毒、高血压、银屑病关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层